

Risco Cardiovascular no Diabetes Mellitus

Vamos fechar nossa discussão sobre diabetes com um tema que vem ganhando cada vez mais espaço nas provas de residência: o manejo do risco cardiovascular no paciente diabético. Esse é um assunto relativamente novo nas diretrizes brasileiras, mas que tem caído com frequência crescente, especialmente em provas que gostam de testar conhecimento atualizado e aplicado à prática clínica.

Antes de entrarmos nos detalhes técnicos, preciso que você entenda um princípio fundamental: **o paciente diabético não é um paciente comum quando falamos de risco cardiovascular**. Ele tem um perfil de risco completamente diferente, e por isso não podemos usar as mesmas calculadoras e os mesmos critérios que aplicamos para a população geral. O diabetes por si só já confere um risco aumentado para eventos cardiovasculares, e isso precisa estar na sua cabeça desde o primeiro momento em que você atende esse paciente.

Vamos começar com um caso clínico bem característico, daqueles que aparecem frequentemente em ambulatórios de atenção básica. Imagina que você está atendendo um paciente de 65 anos com **diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 há 25 anos**, que já desenvolveu **retinopatia diabética**, além de ser **tabagista** e **hipertenso**. Os exames laboratoriais mostram LDL de 75 mg/dL, HDL de 32 mg/dL, triglicerídeos de 150 mg/dL e hemoglobina glicada de 7%. O paciente chega feliz na consulta, todo contente, dizendo que finalmente conseguiu deixar o colesterol dentro da meta. Você, sem querer estragar a alegria dele, mas sendo honesto, precisa explicar que ele ainda vai precisar melhorar bastante esse LDL. E ao final desta aula, você vai saber exatamente qual é a meta lipídica para esse paciente.

Estratificação de Risco Cardiovascular no Diabético

Agora vamos entrar no coração do assunto: como estratificar o risco cardiovascular desse doente. A primeira coisa que você precisa gravar é que **existe uma tabela específica para pacientes diabéticos**. Não adianta tentar usar o Escore de Framingham ou outras calculadoras tradicionais, porque o diabetes já coloca esse paciente em uma categoria diferenciada.

Vamos entender como funciona essa estratificação. O paciente diabético só é considerado de **baixo risco** em uma situação muito específica: quando é um homem com menos de 38 anos ou uma mulher com menos de 46 anos, desde que não apresente nenhum estratificador de alto risco (EAR) nem estratificador de muito alto risco (EMAR). É uma janela bem estreita, e na prática, a maioria dos nossos pacientes diabéticos já vai estar em categorias de risco mais elevadas.

Se estamos falando de um homem entre 38 e 49 anos ou de uma mulher entre 46 e 56 anos, esse paciente já entra como **risco intermediário**, mesmo sem apresentar nenhum estratificador adicional. Perceba como a idade já pesa bastante nessa classificação. E aqui vem um ponto importante: se esse paciente de meia-idade tiver pelo menos um EAR, ele automaticamente sobe para a categoria de **alto risco**.

A categoria de **alto risco** também inclui automaticamente qualquer homem com 50 anos ou mais, ou mulher com 56 anos ou mais. Repare como o critério etário para mulheres é mais permissivo, refletindo a proteção hormonal que elas têm antes da menopausa.

E finalmente, temos a categoria de **muito alto risco**, que engloba pacientes com taxa anual de eventos cardiovasculares superior a 3%. São dois cenários principais que levam a essa classificação: ter um EMAR ou ter três ou mais EARs. Esse é o paciente que você precisa tratar de forma muito agressiva, porque ele está literalmente correndo risco iminente de sofrer um evento cardiovascular grave.

Uma observação importante: se você está diante de um **paciente diabético tipo 1 com menos de 20 anos de doença**, aí sim você pode usar a calculadora tradicional de risco cardiovascular. Mas isso é exceção, não a regra.

Estratificadores de Alto Risco (EAR)

Agora vamos detalhar o que são esses estratificadores de alto risco. Eu vou trazer vários aqui, e não precisa decorar todos de cor, mas é importante ter uma noção geral do que estamos falando. A classificação divide os EARs em quatro grandes grupos: tradicionais, renais, doença aterosclerótica subclínica e biomarcadores.

Nos **EARs tradicionais**, temos aqueles fatores que todo mundo já conhece e que fazem sentido clínico imediato. Primeiro, o próprio **tempo de doença**: se é um DM2 há mais de 10 anos, isso já conta como EAR. Por quê? Porque 10 anos de exposição à hiperglicemia crônica já causaram dano vascular suficiente para aumentar significativamente o risco. Outro EAR tradicional importante é a **história familiar de doença coronariana prematura** - homem <55 anos, mulher <65anos. Isso sugere uma carga genética importante para a aterosclerose acelerada.

Síndrome metabólica definida pelos critérios clínicos também entra como EAR, assim como **hipertensão arterial**, seja tratada ou não, controlada ou não. O simples fato de ser hipertenso já configura um EAR. **Tabagismo** é outro fator óbvio - o cigarro potencializa dramaticamente a disfunção endotelial e a formação de placas ateroscleróticas. Tem ainda a **retinopatia diabética não proliferativa leve** ou um **LDL maior que 190 mg/dL**, que por si só já é um marcador de risco cardiovascular elevado em qualquer população.

Nos **riscos renais**, prestamos atenção na taxa de filtração glomerular e na presença de proteinúria. Se o paciente tem **TFG entre 30 e 59 mL/min**, isso já configura EAR. Ou se a TFG está maior que 45, mas ele tem **microalbuminúria** (entre 30 e 300 mg/g de creatinina) - o famoso critério A2 que discutimos em aulas anteriores - também entra como EAR. O rim é uma janela para a saúde vascular sistêmica, então quando ele começa a falhar, é sinal de que a doença vascular já está disseminada.

Na categoria de **doença aterosclerótica subclínica**, estamos falando daquele paciente que ainda não teve um evento cardiovascular, mas que já tem evidência anatômica de aterosclerose. Por exemplo, **placa carotídea** ao ultrassom, **angiotomografia com placa aterosclerótica** em qualquer território vascular, **índice**

tornozelo-braquial menor que 0,9 (sugerindo doença arterial periférica) ou **aneurisma de aorta abdominal**. São achados que muitas vezes aparecem em exames de rotina e que mudam completamente a estratificação de risco do paciente.

Os **biomarcadores** são uma categoria mais recente e sofisticada. Incluem **lipoproteína (a) maior que 50 mg/dL** (ou maior que 125 nmol/L, dependendo da unidade de medida), **escore de cálcio coronariano maior que 10 unidades Agatston** pelo método de tomografia, ou **NT-proBNP maior que 125 pg/mL**. Esses são marcadores que provavelmente não vão cair na prova de R1, mas é bom você conhecer porque representam o que há de mais moderno na estratificação de risco.

Estratificadores de Muito Alto Risco (EMAR)

Os estratificadores de muito alto risco são mais fáceis de memorizar porque são apenas três grandes categorias. A mais simples é a **prevenção secundária**: qualquer paciente que já teve um evento cardiovascular prévio - infarto, AVC, angina instável, revascularização miocárdica, doença vascular periférica sintomática. Esse paciente, em qualquer score de risco, já seria considerado muito alto risco. No diabetes, não é diferente.

A novidade está na **prevenção primária de alto risco**. Aqui entram três situações específicas. Primeira: ter **três ou mais EARs simultaneamente**. Por exemplo, um paciente tabagista, hipertenso e com história familiar de doença aterosclerótica precoce - isso já configura muito alto risco mesmo sem nunca ter tido um evento cardiovascular. Segunda situação: **DM1 há mais de 20 anos**. Aqui já estamos falando de duas décadas de exposição à hiperglicemia, com lesão vascular cumulativa muito significativa. Terceira: **estenose maior que 50% em qualquer território vascular**, mesmo que assintomática. Uma carótida com obstrução de 60% na angiotomografia, por exemplo, já coloca o paciente em muito alto risco.

Outras condições que entram como EMAR incluem **hipercolesterolemia familiar confirmada** (essa seria muito alto risco em qualquer score), e **retinopatia diabética moderada ou mais grave**. Perceba a diferença: retinopatia leve é EAR, retinopatia

pelo menos moderada é EMAR. Quanto mais avançada a retinopatia, mais disseminada está a microangiopatia diabética, e isso se correlaciona diretamente com risco de macroangiopatia também.

Tem ainda o **EMAR renal**, que é aquele paciente com **TFG maior que 45 mL/min mas com albuminúria franca maior que 300 mg/g**, ou **TFG menor ou igual a 45 mL/min com microalbuminúria**, ou ainda **TFG menor que 30 mL/min** independentemente da proteinúria. Quando o rim está falhando significativamente, o risco cardiovascular dispara.

Metas de LDL e Tratamento

Agora que você já sabe estratificar o risco, vamos às metas terapêuticas. O parâmetro que usamos é o **LDL-colesterol**, não o colesterol não-HDL. Mantenha o foco no LDL.

Para **risco baixo ou intermediário**, a meta é **LDL menor que 100 mg/dL**. Nessa categoria, o uso de estatina é opcional no baixo risco, mas recomendado no intermediário.

Para **alto risco**, a meta é **LDL menor que 70 mg/dL**, e aqui já entramos com **estatina de alta potência** desde o início. É a mesma meta que usamos para pacientes de alto risco não diabéticos.

Para **muito alto risco**, a meta é **LDL menor que 50 mg/dL**. Esse paciente precisa de **estatina de alta potência**, e geralmente precisamos adicionar **ezetimiba** para conseguir atingir essa meta tão agressiva. Em alguns casos refratários, pode ser necessário até **inibidor de PCSK9**, que é um anticorpo monoclonal que consegue reduzir o LDL em até 60% adicional.

Uma coisa interessante que a Sociedade Brasileira de Diabetes traz é uma tabela mostrando o quanto cada esquema terapêutico reduz o LDL. Uma **estatina de alta intensidade** sozinha reduz cerca de 50% do LDL - isso você consegue pelo SUS via alto custo, então é bem acessível. Quando você associa **estatina + ezetimiba**, a

redução chega a 65%. E se você usar **estatina + ezetimiba + PCSK9**, a redução pode chegar a impressionantes 85%. O problema é que o PCSK9 é caríssimo e não está disponível no SUS, então na prática acabamos não usando tanto quanto gostaríamos.

Resolvendo o Caso Clínico da AMP

Vamos agora resolver aquele caso da prova da AMP de 2026 que mencionei no início. Érica, 42 anos, diabética e hipertensa bem controlada há 2 anos, em uso de anticoncepcional oral contínuo, assintomática. Colesterol total de 230 mg/dL, HDL de 31 mg/dL, triglicerídeos de 125 mg/dL, glicemia de jejum de 102 mg/dL, TSH de 1,5 µU/mL, hemoglobina glicada de 6,4%, ácido úrico de 4,5 mg/dL, vitamina D de 30 ng/mL.

A primeira coisa que precisamos fazer é calcular o LDL, porque a questão não nos deu esse valor pronto. Lembrando da **fórmula de Friedewald**: $LDL = \text{Colesterol Total} - HDL - (\text{Triglicerídeos}/5)$. Então: $230 - 31 - (125/5) = 230 - 31 - 25 = 174 \text{ mg/dL}$.

Agora vamos estratificar o risco dessa paciente. Ela tem 42 anos, é mulher, então pela idade estaria naquela faixa de baixo risco (mulher menor que 46 anos). Porém, ela é **diabética e hipertensa**. A hipertensão arterial é um EAR tradicional. Portanto, ela não pode ser classificada como baixo risco. Com 42 anos e pelo menos um EAR, ela sobe para a categoria de **alto risco cardiovascular**.

Sendo alto risco, a meta dela é **LDL menor que 70 mg/dL**. Ela está com 174, bem longe da meta. O tratamento indicado é **estatina de alta intensidade** para tentar atingir $LDL < 70$.

Analisando as alternativas da questão, a letra E sugere ômega-3 e evitar estatina porque aumenta a glicemia. Isso está completamente errado. Embora seja verdade que as estatinas possam aumentar discretamente a glicemia (cerca de 5-10 mg/dL em média), o benefício cardiovascular supera imensamente esse pequeno efeito colateral. Nunca deixamos de usar estatina em diabético por medo de hiperglicemia.

A letra D sugere estatina de alta intensidade + ezetimiba + fenofibrato. Primeiro problema: ela não tem indicação de fenofibrato porque o triglicérido está em 125, bem abaixo do limiar de 500 mg/dL que justificaria fibrato. Segundo problema: ela não é muito alto risco, então não há indicação de iniciar já com terapia tripla incluindo ezetimiba.

A letra C sugere estatina de alta intensidade + ezetimiba para atingir LDL < 50. De novo, a meta dela não é 50, é 70, porque ela é alto risco, não muito alto risco.

A letra B sugere estatina de intensidade moderada para LDL < 100. Isso estaria subestimando o risco dela. Com um EAR, ela é alto risco e precisa de meta < 70 com estatina de alta intensidade.

A **letra A** é a correta: estatina de alta intensidade para atingir LDL < 70 mg/dL. Essa questão inicialmente foi divulgada com gabarito B, mas após recursos, o gabarito foi corrigido para A, que é o correto segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes.

Voltando ao Primeiro Caso

Lembra daquele paciente do início da aula? Homem de 65 anos, DM2 há 25 anos, com retinopatia, tabagista e hipertenso, com LDL de 75 mg/dL? Vamos estratificar ele agora que você já domina o assunto.

Ele tem 65 anos (homem maior que 50 anos = pelo menos alto risco). Tem DM2 há 25 anos (mais de 10 anos = EAR). É tabagista (EAR). É hipertenso (EAR). Tem retinopatia pré-estabelecida. Se for uma retinopatia leve, é EAR. Se for moderada ou mais grave, é EMAR.

Considerando que ele tem múltiplos EARs (pelo menos 3: diabetes > 10 anos, tabagismo, hipertensão), ele provavelmente é **muito alto risco**. Se a retinopatia for pelo menos moderada, fecha o diagnóstico de muito alto risco. Portanto, a meta dele é **LDL menor que 50 mg/dL**. Ele está com 75, então ainda precisa melhorar

bastante, provavelmente adicionando ezetimiba à estatina de alta potência que ele já deve estar usando.

Comentário Final e Pegadinhas de Prova

Alguns pontos que você não pode esquecer na hora da prova. Primeiro: **paciente diabético tem estratificação de risco própria**, não use calculadoras tradicionais. Segundo: **hipertensão arterial é um EAR**, independentemente de estar tratada ou controlada - esse é um ponto que cai muito. Terceiro: **três ou mais EARs = muito alto risco**, mesmo em prevenção primária. Quarto: as **metas de LDL** são as mesmas que para não diabéticos da mesma categoria de risco (alto risco = < 70 , muito alto risco = < 50), mas a forma de chegar nessas categorias é diferente.

Uma **pegadinha comum** é a questão apresentar um paciente diabético jovem, sem nenhum EAR aparente, e você pensar que ele é baixo risco. Leia com atenção: se ele tiver qualquer EAR escondido ali (por exemplo, pai que infartou jovem, ou uma microalbuminúria discreta, ou um ITB de 0,85 que passou despercebido), ele sobe para alto risco. As provas adoram colocar essas informações meio escondidas no enunciado.

Outra **pegadinha clássica** é confundir os critérios de EMAR renal. Preste atenção: TFG entre 30-59 é apenas EAR, não EMAR. Para ser EMAR renal, precisa ou ter TFG ≤ 45 com qualquer grau de albuminúria, ou TFG < 30 independente de proteinúria, ou TFG > 45 mas com albuminúria franca > 300 mg/g.

Por fim, não se assuste se a questão trazer valores de biomarcadores como lipoproteína (a) ou escore de cálcio. Eles são EARs, mas raramente são cobrados em detalhes em provas de R1. O foco costuma ser nos EARs tradicionais e renais, que são os mais prevalentes e clinicamente relevantes.

Com isso, você está pronto para enfrentar qualquer questão sobre risco cardiovascular em diabetes mellitus. É um tema em ascensão nas provas, então vale muito a pena dominar essa estratificação e essas metas terapêuticas. Boa sorte nos estudos!